GUIA DE PRECISÃO CIRÚRGICA

Saúde da Próstata, Urina & Cirurgia Minimamente Invasiva

Como funcionam o rastreio prostático moderno (Ressonância PI-RADS), a proteção da bexiga e os tratamentos a Laser (HoLEP), Rezum e Cirurgia Robótica.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA CLÍNICO:

- A diferença anatômica e clínica entre Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) e Câncer de Próstata;
- Como a Ressonância Multiparamétrica (PI-RADS) evita biópsias desnecessárias e aumenta a precisão diagnóstica;
- Por que urinar fraco ou acordar à noite (noctúria) sobrecarrega a parede da bexiga silenciosamente;
- Tecnologias sem corte abdominal (Laser HoLEP, Vapor d'Água Rezum e Cirurgia Robótica Da Vinci).

Dr. Felipe de Bulhões

MÉDICO · Urologista & Cirurgião Geral · CRM-SP 202.291 | RQE 146538 / 114019
Residência em Urologia pelo Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa (IDOR-SP) · Titular do CBC (TCBC)

TCBC · IDOR-SP · SBU · AUA · EAU
SÃO PAULO & CAMPINAS

Olá! Sou o Dr. Felipe de Bulhões, médico Urologista (IDOR) e Cirurgião Geral (TCBC).

O cuidado com a próstata passou por uma revolução tecnológica nos últimos anos. Hoje, nosso foco não é apenas detectar doenças precocemente, mas preservar integralmente a qualidade de vida do homem: um sono contínuo sem acordar várias vezes para urinar, preservação da função da bexiga, continência urinária e potência sexual. Este guia explica os recursos mais modernos disponíveis em São Paulo e Campinas.

1. Próstata Aumentada (HPB) vs. Câncer de Próstata: Entenda a Diferença

Uma das maiores fontes de ansiedade no consultório é confundir o crescimento benigno da próstata com o câncer. Embora ambos possam elevar o PSA no sangue, trata-se de condições distintas que surgem em regiões diferentes da glândula:

CARACTERÍSTICA	HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)	CÂNCER DE PRÓSTATA (NEOPLASIA)
Zona Anatômica	Cresce na **Zona de Transição** (centro da próstata, abraçando o canal da uretra).	Surge em 75–80% dos casos na **Zona Periférica** (borda externa da próstata).
Sintomas Iniciais	Causa sintomas precoces: jato urinário fraco, demora para iniciar a micção, urgência e acordar à noite.	**Totalmente silencioso** nas fases iniciais (não comprime a uretra no começo).
Relação entre Ambos	A HPB **não vira câncer**, mas exige tratamento quando obstrui a bexiga ou afeta a qualidade de vida.	Tem **mais de 90–95% de chance de cura** quando diagnosticado precocemente no rastreio.

2. Rastreio Inteligente: PSA, Ressonância PI-RADS e Biópsia por Fusão

Seguindo as diretrizes da **Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)** e da **EAU**, recomendamos iniciar a avaliação individualizada aos **45 anos** (para homens com histórico familiar de câncer de próstata/mama ou afrodescendentes) e aos **50 anos** para a população geral.

O FIM DAS BIÓPSIAS "ÀS CEGAS"

Quando o PSA apresenta oscilação, não indicamos biópsia imediata de forma automática. Utilizamos a **Ressonância Magnética Multiparamétrica da Próstata (classificação PI-RADS 1 a 5)** para mapear milimetricamente a glândula. Se houver área suspeita (PI-RADS 4 ou 5), realizamos a **Biópsia Transperineal com Fusão de Imagens** sob sedação — técnica de altíssima precisão e baixíssimo risco infeccioso.

3. Por Que Não Ignorar o Jato Fraco: Protegendo a Bexiga e os Rins

Quando a próstata aumentada comprime a uretra, a **bexiga** precisa fazer até 3 vezes mais força para expulsar a urina. Com o passar dos anos, a musculatura vesical (detrusor) engrossa, perde elasticidade, forma divertículos e pode evoluir para retenção urinária ou sobrecarga renal. A **Avaliação Urodinâmica** e a urofluxometria nos permitem identificar o momento exato de intervir antes que a bexiga perca sua força contrátil.

4. Tecnologias Minimamente Invasivas (Laser, Rezum e Robótica)

TECNOLOGIA CIRÚRGICA	INDICAÇÃO PRINCIPAL	DIFERENCIAIS DE RECUPERAÇÃO
Terapia com Vapor d'Água (Rezum) / UroLift	HPB leve a moderada em homens que desejam evitar uso contínuo de medicamentos e preservar a ejaculação.	Procedimento endoscópico ambulatorial rápido; preserva >90% da função ejaculatória anterógrada.
Enucleação Prostática a Laser (HoLEP / ThuLEP)	HPB moderada a volumosa (inclusive próstatas >80g–150g), substituindo a cirurgia aberta tradicional.	Realizada 100% pelo canal da uretra (sem cortes), mínimo sangramento e alta hospitalar em 24–48h.
Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser	Cálculos renais e ureterais (pedras nos rins) de qualquer densidade.	Microfibra óptica flexível com fragmentação a Holmium/Thulium Laser (pulverização sem incisões).
Cirurgia Robótica (Plataforma Da Vinci)	Câncer de próstata localizado (Prostatectomia Radical) e tumores renais (Nefrectomia Parcial).	Visão 3D HD ampliada em 10x e pinças articuladas em 360° para preservação máxima de potência e continência.

Autoavaliação de Sintomas Urinários e Prostáticos (Baseada no IPSS): AUTOAVALIAÇÃO CLÍNICA

- ☐ Sensação de que a bexiga não esvaziou completamente após terminar de urinar;
- ☐ Jato urinário mais fraco, fino, dividido ou que interrompe e recomeça;
- ☐ Urgência urinária (dificuldade para segurar a urina quando surge a vontade);
- ☐ Necessidade de urinar novamente em menos de 2 horas após a última micção;
- ☐ Necessidade de levantar 2 ou mais vezes durante a noite para urinar (noctúria);
- ☐ Usa medicamentos para próstata (tansulosina/dutasterida) com efeitos colaterais ou pouca melhora.

Importante: Sintomas urinários persistentes ou uso prolongado de medicações sem reavaliação merecem investigação especializada para proteger a função vesical.

5. Excelência Hospitalar e Segunda Opinião Cirúrgica

Quando uma cirurgia urológica ou biópsia é indicada, a escolha da técnica e a experiência da equipe cirúrgica fazem toda a diferença no pós-operatório. Como **Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (TCBC)** e urologista formado pelo **Instituto D'Or (IDOR)**, realizo procedimentos nos principais centros cirúrgicos de São Paulo e Campinas (Rede D'Or São Luiz, Campinas Day Hospital e hospitais de referência), com suporte completo da nossa equipe para planejamento cirúrgico e orientações de convênio/reembolso.

Locais Oficiais de Atendimento & Teleconsulta

São Paulo — Clinovi Paulista
Av. Paulista, 1048, 18º andar — Bela Vista, São Paulo - SP

São Paulo — Clinovi Pinheiros
Av. Rebouças, 2636 — Pinheiros, São Paulo - SP

Campinas — Campinas Day Hospital
Av. Benjamin Constant, 1991 — Cambuí, Campinas - SP

Campinas — Hospital São Luiz Campinas (Rede D'Or)
Av. Andrade Neves, 863 — Centro, Campinas - SP · + Teleconsulta

Próximo Passo: Avaliação Médica Individualizada

Deseja discutir seu caso com discrição absoluta, precisão diagnóstica e plano terapêutico sob medida? Nossa equipe de atendimento está pronta para orientar seu agendamento presencial ou por teleconsulta.

Falar no WhatsApp: (11) 98112-4455 | **Agendar pelo Site Oficial**

Ciência • Saúde • Discrição • Resultados • Masculinidade • Longevidade

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS & CONFORMIDADE ÉTICA (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.336/2023)

1. Cornu JN, Gacci M, Hashim H, et al. EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). European Association of Urology, 2025/2026.
2. Cornford P, Tilki D, van den Bergh RCN, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Eur Urol, 2025.
3. Sandhu JS, Bixler BR, Dahm P, et al. Management of Lower Urinary Tract Symptoms Attributed to Benign Prostatic Hyperplasia: AUA Guideline. J Urol. 2024.
4. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 2.336/2023. Material informativo elaborado pelo Dr. Felipe de Bulhões (CRM-SP 202.291 | RQE 146538 / 114019).